

Ang sacrocolpopexy ay isa sa pinaka-matibay na pamamaraan para sa prolapse (pagbaba ng organ) ng **tuktok ng puki o matris** (ang apex). Ginagamit ang malambot na mesh para itaas ang tuktok ng puki at ikabit ito sa matibay na litid sa ibabaw ng buto ng sacrum, na nagbabalik ng natural na posisyon at lalim. Karaniwang ginagawa ito sa pamamagitan ng keyhole surgery (robotic o laparoscopic) at pinapanatili ang kakayahang makipagtalik.

Tungkol sa Operasyong Ito

Isang piraso ng **mesh** ang ikinakabit sa harap at likod ng tuktok ng puki, pagkatapos ay isineselyuho sa matibay na litid ng **sacrum**. Pinapanatili nito ang puki sa tamang posisyon. Itinuturing itong **pinakamainam** na pamamaraan para sa apical prolapse dahil napaka-matibay ng resulta.

Tungkol sa Mesh

Ang mesh na ginagamit dito ay inilalagay sa pamamagitan ng **tiyan** at matagal nang pinag-aralan ang kaligtasan nito. Ito ay **naiiba** sa transvaginal mesh (mesh na inilagay sa puki) para sa prolapse na binanggit sa mga babala ng FDA at tinanggal na sa merkado. Tatalakayin ng inyong siruhano ang mga maliit na panganib, kasama ang bihirang pagkakataon ng mesh exposure.

MGA TERMINO

Apex / vault

Ang tuktok ng puki, na maaaring bumaba pagkatapos ng panganganak o hysterectomy.

Sacrum

Buto sa dulo ng gulugod; ang litid nito ang nagsisilbing anchor ng operasyon.

Mesh

Malambot na permanenteng materyales para suportahan ang tuktok ng puki.

Robotic / laparoscopic

Keyhole surgery sa pamamagitan ng ilang maliit na hiwa.

Mesh exposure

Bihirang problema kung saan may maliit na bahagi ng mesh na nagiging visible; maaaring gamutin.

Hysterectomy

Pag-alis ng matris, na minsan ay kasabay ng operasyong ito.

MASAKIT BA? Ginagawa ito sa ilalim ng general anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman habang nag-oopera. Sa keyhole surgery, karaniwang may katamtamang sakit sa maliit na mga hiwa at kaunting gas discomfort, at makakauwi kayo sa parehong araw o pagkatapos ng isang gabi. Ang mas malaki o open surgery ay nangangailangan ng kaunti pang pahinga.

Paano Maghanda

- Ginagawa sa ilalim ng **general anesthesia** — sundin ang mga tagubilin sa pag-aayuno at gamot (ihinto ang blood thinners ayon sa utos).
- Kakailanganin ng pre-op evaluation; maaaring isama ang **hysterectomy** at/o operasyon para sa incontinence.
- Huwag manigarilyo; mag-ayos ng sakay at tulong sa bahay.

Ano ang Nangyayari

- 1 Natutulog kayo; binibigyan ng antibiotics.
- 2 Sa pamamagitan ng keyhole incisions (o isang bukas na hiwa), ikinakabit ang mesh sa tuktok ng puki.
- 3 Isineselyuho ang mesh sa sacral ligament, itinatayo ang puki sa tamang lugar.
- 4 Inilalagay ang catheter sa maikling panahon.

Pagkatapos ng Operasyon

- Makakauwi sa parehong araw o pagkatapos ng isang gabi; magaan na gawain muna.
- **Iwasan ang mabigat na pagbubuhat, pag-igting, at pakikipagtalik sa loob ng humigit-kumulang 6 na linggo.**
- Normal ang kaunting spotting at banayad na sakit; gamutin ang konstipasyon.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Matinding pagdurugo, o lumalalang sakit sa tiyan o pelvis
- **Hindi makaihi**, o patuloy na pagduwal/pagsusuka
- Vaginal discharge na may amoy, o sakit sa pakikipagtalik paglaon (posibleng mesh issue)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Itinatayo ng sacrocolpopexy ang tuktok ng puki gamit ang mesh na nakaangkla sa sacrum — pinaka-matibay na pamamaraan para sa apical prolapse, karaniwang keyhole.
2. Ang abdominal mesh nito ay matagal nang pinag-aralan at naiiba sa tinanggal na transvaginal prolapse mesh.
3. Iwasan ang mabigat na pagbubuhat at pakikipagtalik sa loob ng ~6 na linggo. Tumawag para sa lagnat, matinding pagdurugo, hindi makaihi, o amoy/sakit paglaon.